GUIDE COMPLET

La Colère, *Enfin Apprivoisée*

Comprendre cette émotion, et des outils concrets pour la traverser autrement.



Alain Zenatti
Hypnothérapeute
NovaHypnose · Paris 4e · novahypnose.fr

AU PROGRAMME

Six chapitres, *une idée simple*

Comprendre ce qui se passe dans votre cerveau quand la colère monte, ce qui ne fonctionne pas, et construire une réponse différente.

01 Pourquoi ressentez-vous de la colère ? Ce qui se passe dans votre cerveau

02 Les 3 profils de la colère

03 Pourquoi « se contrôler » ne suffit pas, et pourquoi c'est normal

04 Ce que la science dit de l'hypnose et de la régulation émotionnelle

05 Votre programme pratique : désamorcer la colère au quotidien

06 Quand consulter ? Ce que l'hypnothérapie peut faire pour vous

AVANT DE COMMENCER

Ce guide propose des pistes de réflexion. Il ne remplace ni un avis médical ni un suivi psychologique ou psychiatrique. En cas de détresse, appelez le 3114 (numéro national de prévention du suicide).

INTRODUCTION

Vous en avez assez d'exploser pour un rien, ou d'avaler votre colère

Peut-être que vous claquez une porte, que vous élevez la voix plus fort que vous ne le vouliez, et qu'ensuite vient la honte, le « je ne me reconnais pas ». Ou peut-être que c'est l'inverse : vous ravalez tout, vous souriez alors que ça bouillonne à l'intérieur, et cette colère jamais dite finit par vous user, au travail, en couple, dans le corps.

Ce guide n'est pas là pour vous apprendre à « vous calmer » : vous avez sans doute déjà essayé, et ça ne suffit pas toujours. Il est là pour poser une idée simple.

> *« La colère n'est pas votre ennemie. C'est un signal. Et un signal mal écouté devient un problème, pas parce que vous êtes « trop » quelque chose, mais parce que personne ne vous a appris à l'entendre autrement qu'en la combattant ou en la subissant. »*
>
> Alain Zenatti

22 %

des salariés dans le monde déclarent avoir ressenti beaucoup de colère la veille (Gallup, *State of the Global Workplace*, 2026 ; 15 % en Europe)

7,3 %

prévalence du trouble explosif intermittent sur la vie entière, aux États-Unis (Kessler et al., 2006)

Ces chiffres ne disent pas la même chose : le premier est un instantané émotionnel des salariés dans le monde, le second une prévalence clinique américaine. Ce qu'ils montrent ensemble : la colère mal régulée n'est ni rare, ni marginale, ni honteuse.

La bonne nouvelle : la colère n'est pas un trait de caractère gravé dans le marbre. C'est largement une réaction apprise, et ce qui s'apprend peut se réapprendre.

CHAPITRE

01

Pourquoi ressentez-vous de la colère ? *Ce qui se passe dans votre cerveau*

Votre cerveau ne vous trahit pas. Il vous protège, parfois avec quelques secondes d'avance sur votre raison.

Le réflexe d'alarme : l'amygdale en première ligne

Face à une situation perçue comme une menace, une injustice ou une frustration, une petite structure du système limbique, l'amygdale, s'active en quelques fractions de seconde. Elle envoie un signal à l'hypothalamus, qui active le système nerveux sympathique et déclenche la libération d'adrénaline, de noradrénaline et de cortisol, les hormones du « combat ou fuite ».

Ce circuit d'alarme est plus rapide que la pensée consciente : la colère peut surgir avant même que vous ayez identifié ce qui l'a déclenchée. Cœur qui s'accélère, mâchoire qui se serre, chaleur au visage, respiration qui se raccourcit : ce sont les signatures physiques de cette réponse automatique.

Le « détournement de l'amygdale »

Le psychologue Daniel Goleman a popularisé, dans *L'Intelligence émotionnelle* (1995), l'expression « détournement de l'amygdale » (*amygdala hijack*) pour décrire le moment où l'alarme émotionnelle prend le pas sur le raisonnement : le cortex préfrontal, la zone qui évalue, pondère, décide, voit son activité réduite pendant que l'amygdale s'emballe.

Des travaux en neuro-imagerie suggèrent que, chez les personnes qui régulent bien leur colère, le cortex préfrontal reste activé pendant la montée émotionnelle, ce qui module la réponse de l'amygdale. Chez celles qui ont plus de mal à réguler leurs réactions, on observe une activité préfrontale réduite associée à une amygdale plus réactive.

Une fonction longtemps incomprise

Le psychosociologue Jacques Salomé, fondateur de la méthode ESPERE®, propose une lecture différente : la colère aurait une fonction de protection. Elle signalerait qu'une limite a été franchie, qu'un territoire physique ou psychologique a été envahi. Dans cette approche, la seule colère réellement problématique serait celle que l'on retourne contre soi-même.

C'est une nuance importante : l'objectif n'est pas de supprimer la colère, mais de lui redonner une fonction utile, celle d'un signal que l'on sait entendre et exprimer, plutôt que celle d'une décharge que l'on subit.

> À RETENIR
>
> La colère est une réaction neurophysiologique rapide, pas un défaut moral. Elle sert, à l'origine, une fonction de protection. Le problème n'est pas de la ressentir : c'est de ne pas savoir l'écouter autrement qu'en explosant ou en l'étouffant.

CHAPITRE

02

Les 3 profils *de la colère*

Il n'existe pas « une » colère. Selon la façon dont elle s'exprime, on distingue généralement trois grandes tendances, souvent mêlées chez une même personne.

Profil	Ce que vous ressentez	Ce que cela révèle
1. Colère rentrée	Vous « avalez » votre colère. Vous souriez, vous restez calme en apparence, pendant que ça bouillonne à l'intérieur.	Le corps encaisse ce que la voix ne dit pas. La question : comment exprimer sans se mettre en danger relationnel ?
2. Colère explosive	La tension monte vite et déborde : mots durs, ton élevé, geste brusque, suivis souvent de regret ou de honte.	L'énergie sort, mais sans filtre. La question : comment ralentir le passage de l'impulsion à l'acte ?
3. Colère chronique	Une irritabilité de fond, un seuil de tolérance bas, l'impression d'être « à cran » plus souvent qu'à votre tour.	Le terrain est déjà saturé avant même le déclencheur. La question : qu'est-ce qui alimente ce fond de tension ?

Cette distinction s'inspire des dimensions étudiées depuis les années 1980 par le psychologue Charles Spielberger, qui a montré que la colère se décrit selon plusieurs axes indépendants : son intensité du moment, sa fréquence habituelle, et la façon dont elle est exprimée, vers l'extérieur, vers l'intérieur, ou maîtrisée.

> À RETENIR
>
> La plupart des personnes combinent deux profils, voire les trois selon le contexte. L'enjeu n'est pas de se coller une étiquette, mais de repérer votre tendance dominante : la stratégie pour l'apaiser n'est pas la même selon qu'on retient trop ou qu'on explose trop vite.

CHAPITRE

03

Pourquoi « se contrôler » *ne suffit pas, et pourquoi c'est normal*

Deux stratégies spontanées existent face à la colère : la retenir, ou la laisser sortir. Les données de la recherche suggèrent que, seules, ni l'une ni l'autre ne fonctionnent durablement.

Le mythe de la décharge : « ça fait du bien de se défouler »

L'idée qu'exprimer physiquement sa colère (frapper un coussin, crier, taper dans un sac de sport) la fait diminuer est largement répandue : c'est la « théorie de la catharsis ». Une étude expérimentale de référence a testé cette hypothèse : des participants en colère devaient soit frapper un punching-ball en ruminant contre la personne qui les avait provoqués, soit se distraire, soit ne rien faire.

Résultat : ne rien faire s'est révélé plus efficace pour réduire l'agressivité ultérieure que de « se défouler ». Le groupe qui avait rejoué sa colère en frappant est resté le plus agressif. La décharge physique n'éteint pas la colère : elle semble l'entretenir (Bushman, 2002).

Le mythe du contrôle pur : « il suffit de se retenir »

À l'inverse, réprimer systématiquement sa colère ne la fait pas disparaître : elle reste physiologiquement active. Le corps qui a mobilisé de l'adrénaline et du cortisol pour « agir » et qui n'agit pas garde cette activation en tension. Répétée, cette suppression chronique est associée, dans la littérature de psychologie de la santé, à une charge physique et relationnelle qui s'accumule.

Ce qui fonctionne mieux : les approches structurées

Une méta-analyse portant sur 50 études et 1 640 participants a évalué l'efficacité des thérapies cognitivo-comportementales (TCC) sur la colère. Elle trouve un effet moyen pondéré de 0,70 (une taille d'effet large en sciences sociales) : un participant moyen ayant suivi une TCC se portait mieux que 76 % des personnes non traitées (Beck & Fernandez, 1998).

Ce résultat montre que ce qui aide n'est ni la volonté brute, ni le défoulement, mais une approche structurée qui travaille sur les pensées, les déclencheurs et les automatismes, le terrain sur lequel intervient aussi l'hypnose ericksonienne (repérage des déclencheurs, restructuration, ancrage de nouvelles réponses).

> À RETENIR
>
> Ni la suppression ni l'explosion ne semblent réduire durablement la colère : l'une l'accumule, l'autre l'entretient. Ce qui a fait ses preuves, ce sont les approches structurées qui travaillent sur les déclencheurs et les automatismes, pas la volonté seule.

CHAPITRE

04

Ce que la science dit *de l'hypnose et de la régulation émotionnelle*

Soyons directs : la recherche sur l'hypnose appliquée spécifiquement à la colère est moins abondante que sur le sommeil ou la douleur. Mieux vaut le dire clairement.

Ce que l'on sait avec un bon niveau de preuve concerne surtout deux choses : ce qui se passe dans le cerveau pendant l'hypnose en général, et l'effet de l'hypnose sur la détresse psychologique et le stress, un terrain proche de la régulation de la colère.

Ce qui se passe dans le cerveau pendant l'hypnose

Une étude de neuro-imagerie de l'équipe du Dr David Spiegel (université de Stanford) a comparé, par IRM fonctionnelle, l'activité cérébrale de 57 personnes pendant l'hypnose (Jiang et al., 2017). Chez les sujets hautement hypnotisables, trois changements sont apparus, absents au repos ou pendant un simple rappel de souvenir :

- une baisse d'activité du cortex cingulaire antérieur dorsal, une zone du « réseau de la saillance » qui gère ce à quoi l'on prête attention et ce qui inquiète ;
- une connexion renforcée entre le cortex préfrontal dorsolatéral et l'insula : une meilleure communication entre le cerveau et les sensations corporelles ;
- une connexion réduite entre le cortex préfrontal dorsolatéral et le réseau du mode par défaut, associé à l'auto-évaluation et à la rumination : un possible mécanisme de mise à distance vis-à-vis de la réaction automatique.

Moins d'inquiétude, plus de connexion corps-cerveau, moins d'auto-jugement : c'est ce que l'on vise en séance quand on travaille sur les réponses automatiques de colère, pour créer un espace entre le déclencheur et la réaction.

Ce que montrent les études sur hypnose, stress et détresse

Une revue systématique de cinq essais contrôlés randomisés a évalué une approche combinant hypnose et pleine conscience (Padilla et al., *Behavioral Sciences*, 2026). Sur trois essais, l'effet sur la détresse psychologique est moyen (g = 0,61), mais l'intervalle de confiance est très large (de 0,10 à 1,12) : le résultat reste incertain.

La colère chronique et le stress partagent une bonne partie de leur circuiterie physiologique. Ces résultats ne prouvent pas directement l'efficacité de l'hypnose sur la colère, mais ils rendent l'hypothèse plausible.

HONNÊTETÉ SCIENTIFIQUE

Il n'existe pas, à ce jour, d'essai contrôlé randomisé de grande ampleur portant spécifiquement sur « hypnose contre colère ». Ce guide s'appuie donc sur trois éléments présentés comme tels : le mécanisme cérébral général de l'hypnose (Spiegel et al.), l'effet de l'hypnose sur le stress et la détresse psychologique, et l'efficacité des approches cognitives structurées sur la colère (Beck & Fernandez). L'hypnose ericksonienne que je pratique s'inscrit dans cette logique : travailler sur les déclencheurs et les automatismes, sans prétendre à une preuve spécifique qui n'existe pas encore.

CHAPITRE

05

Votre programme pratique : *désamorcer la colère au quotidien*

Ces actions ne demandent pas « plus de volonté » : elles demandent de la méthode, au bon moment.

Étape 1 : repérer les signaux avant-coureurs

Avant l'explosion ou le repli, le corps prévient : mâchoire qui se serre, chaleur au visage ou à la nuque, respiration qui se raccourcit, voix qui monte d'un ton. Notez vos 3 signaux les plus fréquents : ce sont vos alarmes précoces, le moment où il est encore possible d'intervenir.

Étape 2 : utiliser la fenêtre physiologique

Sur le plan hormonal, le pic d'adrénaline retombe en quelques minutes, mais ses effets peuvent se prolonger 20 à 60 minutes ; le cortisol a une demi-vie plasmatique d'environ 60 à 90 minutes (valeurs de référence en physiologie ; elles varient selon les personnes). Concrètement : la réaction physiologique de la colère ne s'éteint pas instantanément, mais elle décroît vite si vous ne la relancez pas par la rumination ou la confrontation immédiate.

- Sortez de la pièce ou changez de position si possible, sans claquer la porte : « J'ai besoin d'une pause, je reviens vers toi. »
- Ne prenez aucune décision, n'envoyez aucun message, tant que le pic n'est pas redescendu.

Étape 3 : la respiration qui calme le système nerveux

Inspirez 4 secondes par le nez, expirez lentement 6 secondes par la bouche. Répétez 8 à 10 fois. Une expiration plus longue favorise le passage du système nerveux vers son mode parasympathique, celui du repos, à l'opposé du mode « combat ou fuite ».

Étape 4 : le message « je », pas le message « tu »

Inspirée des travaux de Jacques Salomé sur la communication relationnelle (méthode ESPERE®), cette étape consiste à remplacer l'accusation par la description de son propre ressenti. Non pas « Tu es toujours en retard », mais « Je suis en colère quand j'attends sans nouvelles, parce que le respect de mon temps compte pour moi. » Le message reste ferme, mais il ferme moins la porte au dialogue qu'une accusation frontale.

Étape 5 : prendre soin de l'émotion, plutôt que la combattre

Une fois le pic redescendu, la colère mérite d'être écoutée plutôt qu'ignorée : qu'est-ce qu'elle protégeait ? Quelle limite a été franchie ? Jacques Salomé invite à « prendre soin » de son émotion : lui accorder un espace et un temps dédiés, plutôt que la nier ou la laisser s'accumuler en silence.

Étape 6 : l'ancrage par l'auto-hypnose

En dehors des montées de tension, entraînez un ancrage : un geste discret (presser le pouce et l'index, poser la main sur le sternum) associé mentalement à un état de calme profond, construit en état de relaxation. Répété régulièrement hors contexte de colère, ce geste peut ensuite être utilisé au moment où la tension commence à monter, pour rappeler au corps un état différent de celui de l'alerte.

Auto-évaluation indicative

Cette grille n'est pas un outil clinique validé. Elle s'inspire des dimensions reconnues dans la recherche sur la colère (fréquence, intensité, mode d'expression, retentissement physique) pour vous aider à situer où vous en êtes aujourd'hui.

Question	0 point	1 point	2 points
À quelle fréquence sentez-vous la colère monter en moins de quelques secondes ?	Rarement	Parfois	Souvent
Après une montée de colère, regrettez-vous votre réaction (mots, gestes, silence) ?	Jamais	Parfois	Souvent
Vous arrive-t-il de « ravaler » votre colère au point de sourire alors que ça bouillonne ?	Non	Parfois	Souvent
Votre entourage vous a-t-il déjà dit qu'il « marche sur des œufs » avec vous ?	Non	Une fois	Régulièrement
La colère laisse-t-elle des traces physiques après coup (mâchoire serrée, tensions, fatigue) ?	Non	Parfois	Souvent

Interprétation indicative :

- Score de 0 à 3 : colère globalement bien régulée. Les outils de ce chapitre suffisent probablement à consolider.
- Score de 4 à 6 : colère qui commence à peser. Un accompagnement peut accélérer et sécuriser le changement.
- Score de 7 à 10 : colère qui affecte votre quotidien ou vos relations. Un accompagnement est recommandé, en particulier si des gestes ou des paroles dépassent ce que vous souhaiteriez.

CHAPITRE

06

Quand consulter ? *Ce que l'hypnothérapie peut faire pour vous*

Les techniques de ce guide sont utiles au quotidien. Mais certaines colères méritent un accompagnement personnalisé, notamment quand elles se répètent, s'intensifient, ou pèsent sur vos relations.

CONSULTEZ UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ EN PREMIER SI

Votre colère s'accompagne de pensées ou de passages à l'acte violents envers vous-même ou autrui, d'une consommation d'alcool ou de substances associée aux épisodes, ou d'un contexte de violences conjugales ou familiales. L'hypnothérapie vient en complément d'un suivi médical ou psychiatrique, jamais en remplacement. En cas d'urgence ou de danger immédiat : 15 (SAMU) ou 17 (Police). Violences conjugales : 3919 (appel anonyme et gratuit, France).

Ce qu'une séance d'hypnothérapie peut apporter

- identifier les déclencheurs récurrents et ce qu'ils réactivent réellement (une peur, une blessure ancienne, un besoin de reconnaissance non satisfait) ;
- travailler, en état hypnotique, sur les associations automatiques entre un contexte et la montée de tension, pour élargir l'espace entre le déclencheur et la réaction ;
- installer un ancrage corporel personnalisé, accessible en quelques secondes dans une situation réelle ;
- renforcer les ressources internes (calme, recul, affirmation de soi) plutôt que de simplement « travailler sur » la colère elle-même ;
- faire la part, avec vous, entre colère légitime à exprimer et colère réactivée par un vécu plus ancien.

À quoi s'attendre

Un accompagnement pour la gestion de la colère se déroule souvent sur 3 à 5 séances. La première séance est la plus longue : environ 1 h 30, avec un temps d'échange approfondi (anamnèse) et un premier travail hypnotique. Les séances suivantes consolident et travaillent sur des situations ou déclencheurs spécifiques.

Je ne peux pas vous promettre de résultat. Mon engagement : si après 2 ou 3 séances rien n'a bougé pour vous, je vous le dis franchement, et je ne vous propose pas de continuer.

Tarif : première séance de 1 h 30, 90 €. Séances suivantes : 1 heure, 90 €. En présentiel à Paris 4e, ou en visioconférence depuis toute la France : un endroit calme, un casque et une connexion stable suffisent.

CONCLUSION

Votre colère peut devenir une alliée, dès aujourd'hui

Vous avez maintenant une compréhension plus claire de ce qui se passe dans votre cerveau quand la colère monte, de ce qui ne fonctionne pas (la retenir totalement, ou la laisser exploser), et des outils pour construire une réponse différente.

L'ESSENTIEL À RETENIR

- La colère est un signal physiologique rapide, pas un défaut de caractère, et ce qui s'apprend peut se réapprendre.
- Ni la suppression ni le défoulement ne semblent fonctionner durablement.
- Les approches structurées (cognitives, relationnelles, hypnotiques) qui travaillent sur les déclencheurs plutôt que sur la volonté sont celles qui montrent des résultats.
- La première étape concrète : repérer vos 3 signaux avant-coureurs, dès aujourd'hui.

> *« Votre calme est là, quelque part en vous. Parfois il a juste besoin d'un peu d'aide pour reprendre sa place. »*
>
> Alain Zenatti

Mettre des mots sur ce qui vous traverse

J'ai préparé 5 questions. Elles prennent 2 minutes. Vous obtenez tout de suite un décryptage personnalisé : ce qui ressort de vos réponses, et quelques pistes pour la suite. C'est gratuit, sans engagement, et vos réponses restent confidentielles.

Faire mon décryptage

Si vous préférez en parler directement, je vous propose un échange de 15 minutes par téléphone, gratuit. On regarde ensemble si l'hypnose est adaptée à votre situation. Si elle ne l'est pas, je vous le dis.

resalib.fr/p/47325

novahypnose.fr/wa

06 49 35 80 89

contact@novahypnose.fr

16 rue Saint-Antoine, 75004 Paris

Alain Zenatti

Hypnothérapeute

SOURCES ET LIMITES

D'où viennent *les chiffres*

Sources citées

- Beck R., Fernandez E. (1998), *Cognitive-Behavioral Therapy in the Treatment of Anger: A Meta-Analysis*, *Cognitive Therapy and Research* 22:63-74.
- Bushman B. J. (2002), *Does Venting Anger Feed or Extinguish the Flame?*, *Personality and Social Psychology Bulletin* 28:724-731.
- Gallup (2026), *State of the Global Workplace: 2026 Report* (données 2025, publié en avril 2026).
- Goleman D. (1995), *Emotional Intelligence*, Bantam Books.
- Jiang H., White M. P., Greicius M. D., Waelde L. C., Spiegel D. (2017), *Brain Activity and Functional Connectivity Associated with Hypnosis*, *Cerebral Cortex* 27(8):4083-4093.
- Kessler R. C. et al. (2006), *The Prevalence and Correlates of DSM-IV Intermittent Explosive Disorder in the National Comorbidity Survey Replication*, *Archives of General Psychiatry* 63(6):669-678.
- Salomé J., méthode ESPERE®.
- Spielberger C. D. (1988, 1999), State-Trait Anger Expression Inventory (STAXI, STAXI-2).
- Padilla V. J., Muñiz V., Scheffrahn K., Elkins G. (2026), *Effect of Mindful Hypnotherapy on Psychological Distress: A Systematic Review and Meta-Analysis*, *Behavioral Sciences* 16(1):107, doi:10.3390/bs16010107.

LIMITES

Ce guide propose des pistes de réflexion. Il ne remplace ni un avis médical ni un suivi psychologique ou psychiatrique. Là où la recherche sur l'hypnose et la colère reste limitée, le guide le signale plutôt que d'extrapoler.